



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PENGORGANISASIAN
NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
(NICU)
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 998.1/I-PDM/NICU/X/2025

Tentang
Pedoman Pengorganisasian Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU)

Disusun oleh :
Kepala Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU)



(dr. Dicky Faturrachman , Sp.A, M. Biomed)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 998.1/I-PDM/NICU/X/2025

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI *NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keperawatan (masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 17/2023). Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien.
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C dan kelas D
8. Pedoman Uraian Tugas Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2023
9. Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2022.
10. Standar Peralatan Keperawatan Dan Kebidanan Di Sarana Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2022.
11. Standar Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2022.
12. Pedoman Perancangan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2022.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

-
14. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada
 16. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT**

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terlampir dalam peraturan ini

Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 129.2/I-PER/DIR/I/2018 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Oktober 2025
PLT DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG



dr. Resti Lestantini, M. Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan KaruniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan Pedoman Pengorganisasian Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit*

Pedoman Pengorganisasian Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* RS Prima Husada Malang Tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi gambaran umum Rumah Sakit Prima Husada hingga struktur organisasi Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan panduan ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku panduan ini.

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI *NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT*

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Pelaksana

1. dr. Resti Lestantini, M. Kes
2. Dhora Putri Meryda, S. Kep. Ns
3. Novita Rosunah W, AMd.keb
4. Sefira Herisky AMd.Kep
5. Ns. Rismaya Felantriardianti, S.Kep
6. Agustia Feronika Sari AMd. Kep
7. Rista Alfia Sari, AMd.Kep
8. Nuraini Radika Rifky, S.Kep.Ns
9. Saudah, S.Kep.Ns
10. Dan seluruh staf di RS Prima Husada Malang

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PENGESAHAN ii

PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA iii

KATA PENGANTAR vii

TIM PENYUSUN viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II STANDAR KETENAGAAN 3

2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia 3

2.2. Distribusi Ketenagaan 3

2.3. Pengaturan Jaga 4

BAB III STANDAR FASILITAS 5

3.1. Denah Ruang 5

3.2. Standar Fasilitas 5

BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN 10

4.1. Pelayanan Rawat Inap Yang Bisa Dilakukan di RSPH 10

4.2. Pelayanan Rawat Inap Yang Tidak Bisa Dilakukan di RSPH..... 10

BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN 11

5.1. Skrining Pasien Masuk Rawat Inap 11

5.2. Penundaan Dan Kelambatan Pelayanan..... 12

5.3. Asuhan Pasien Rawat Inap 12

5.4. Kesenambungan Pelayanan Pasien 12

5.5. DPJP 14

5.6. Transfer Pasien 14

5.7. Pemulangan Dari Rumah Sakit 15

5.8. Penolakan Rencana Asuhan Medis..... 16

5.9. Rujukan Pasien 17

5.10. Transport Pasien 18

BAB VI LOGISTIK..... 19

BAB VII KESELAMATAN PASIEN 22

7.1. Pengertian..... 22

7.2. Tujuan 22

7.3. Standar Keselamatan Pasien 22

7.4. Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan 22

7.5. Tata Laksana 22

BAB VIIIKESELAMATAN KERJA 25

8.1. Latar Belakang 25

8.2. Pengertian..... 25

8.3. Tujuan 25

8.4. Tata Laksana Keselamatan Kerja..... 25

8.5. Prinsip Keselamatan Kerja 26

BAB IX PENINGKATAN MUTU 27

9.1. Prinsip 27

9.2. Definisi Indikator..... 27

9.3. Kriteria..... 28

9.4. Standar 28

BAB X PENUTUP 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Organisasi 5

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Unit Kamar Instalasi Rawat Inap..... 8

Gambar 7.1 Tata Hubungan Kerja..... 15

DAFTAR TABEL

Tabel 8.1 Pola Ketenagaan dan Kualifikasi 17

Tabel 9.1 Kegiatan Orientasi 25

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 998.1/I-PDM/NICU/X/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI *NEONATAL INTENSIVE
CARE UNIT*

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI *NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT*

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu negara. Sebagian besar kematian bayi terjadi pada masa neonatal (0-28 hari), yang sering kali disebabkan oleh komplikasi kelahiran prematur, asfiksia, infeksi, dan kelainan kongenital. Upaya penurunan AKB memerlukan penanganan yang komprehensif, cepat, dan terpadu, salah satunya melalui penyediaan layanan perawatan intensif neonatal yang berkualitas.

Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah unit pelayanan di rumah sakit yang menyediakan asuhan medis dan keperawatan khusus bagi bayi baru lahir dengan risiko tinggi atau kondisi kritis. Mengingat kompleksitas peralatan medis yang digunakan, kerentanan pasien, serta tingginya intensitas pelayanan, NICU tidak hanya membutuhkan kecanggihan teknologi, tetapi juga manajemen pengorganisasian yang kuat.

Pengorganisasian yang efektif di NICU menjadi krusial karena beberapa alasan utama:

1. Kompleksitas Asuhan: Pasien neonatal memerlukan pemantauan kontinu 24 jam dan intervensi yang sangat spesifik, sehingga diperlukan pembagian peran yang jelas antara tenaga medis, keperawatan, dan penunjang.
2. Keamanan dan Keselamatan Pasien: NICU adalah area dengan risiko tinggi terjadinya infeksi nosokomial dan kesalahan prosedur. Struktur organisasi yang baik memastikan implementasi standar keselamatan pasien berjalan secara konsisten.
3. Profesionalisme SDM: Keberhasilan layanan NICU sangat bergantung pada kualifikasi dan kompetensi staf. Diperlukan pengaturan pola ketenagaan dan pengembangan jenjang karir yang terencana untuk menjaga kualitas layanan.
4. Kolaborasi Multidisiplin: Penanganan bayi kritis melibatkan berbagai unit lain (Farmasi, Laboratorium, Radiologi, dan Logistik). Tanpa pedoman tata hubungan kerja yang jelas, efektivitas pelayanan akan terhambat.

Sejalan dengan tuntutan Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES 2022) dan regulasi kesehatan terbaru, setiap unit kerja di rumah sakit wajib memiliki pedoman pengorganisasian sebagai dasar hukum operasional internal. Oleh karena itu, disusunlah Pedoman Pengorganisasian Instalasi NICU ini sebagai acuan dalam mengatur struktur, wewenang, dan tata kerja demi tercapainya pelayanan neonatal yang profesional, bermutu, dan aman.

Upaya untuk mendukung peningkatan mutu dan terlaksananya program kerja di bagian masing-masing diperlukan SDM yang berkualitas. Seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia yang baik diharapkan sebuah institusi dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

1.2. Ruang Lingkup Pengorganisasian NICU

Ruang lingkup pelayanan yang diberikan di NICU adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Organisasi & SDM (Sumber Daya Manusia)
Fokus pada pengaturan personil yang bertugas di unit NICU :
 - a. Struktur Organisasi Unit : Penentuan garis komando antara Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Ketua Tim, hingga Perawat Pelaksana.
 - b. Pola Ketenagaan : Pengaturan jumlah perawat berdasarkan beban kerja dan tingkat ketergantungan pasien (Level I, II, dan III).
 - c. Uraian Tugas (Job Description) : Penjabaran hak, wewenang, dan tanggung jawab setiap posisi agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.
 - d. Kualifikasi & Rekrutmen : Standar kompetensi staf (misalnya sertifikat pelatihan NICU atau Resusitasi Neonatus) dan prosedur penerimaan staf baru.
 - e. Pengembangan Staf : Pengaturan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (Continuing Professional Development).
2. Ruang Lingkup Sarana, Prasarana, & Alat (SPA)
Fokus pada manajemen aset fisik untuk mendukung operasional :
 - a. Manajemen Fasilitas : Pengaturan tata ruang NICU yang sesuai standar (area bersih, area kotor, area isolasi, dan ruang laktasi).
 - b. Inventarisasi Alat Medis : Pengelolaan daftar alat seperti inkubator, ventilator, infusion pump, dan monitor neonatal.
 - c. Pemeliharaan (Maintenance) : Prosedur kalibrasi berkala dan perbaikan alat yang rusak berkoordinasi dengan bagian elektromedik (ATEM).
3. Ruang Lingkup Tata Hubungan Kerja (Koordinasi)
Fokus pada interaksi NICU dengan unit lain di rumah sakit :
 - a. Hubungan Internal : Koordinasi dengan Kamar Bersalin (VK) atau Kamar Operasi (OK) untuk proses serah terima bayi (handover).
 - b. Hubungan Penunjang : Alur kerjasama dengan Laboratorium (pemeriksaan cito), Farmasi (penyediaan nutrisi parenteral/obat), dan Radiologi.
 - c. Hubungan Administrasi : Koordinasi dengan bagian Keuangan/BPJS terkait penjaminan pasien dan bagian Logistik untuk stok BMHP (Barang Medis Habis Pakai).
4. Ruang Lingkup Manajemen Mutu & Keselamatan
Fokus pada pengawasan kinerja unit :
 - a. Indikator Mutu Unit : Pemantauan data seperti angka kematian bayi, angka infeksi nosokomial (HAIs), dan kepuasan pelanggan.
 - b. Keselamatan Pasien : Implementasi 6 Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) di tingkat unit.
 - c. Manajemen Risiko : Identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja NICU (K3RS) dan mitigasinya.
5. Ruang Lingkup Sistem Pelaporan
Fokus pada alur informasi :
 - a. Laporan Internal : Laporan shift, sensus harian, dan laporan bulanan kepada pimpinan rumah sakit.
 - b. Laporan Eksternal : Pelaporan data kelahiran atau kematian bayi ke Dinas Kesehatan (jika diperlukan) melalui sistem informasi rumah sakit (SIRS).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan bagi unit kerja dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Prima Husada Malang.

2. Tujuan

- a. Memudahkan bagi pemberi jasa pelayanan Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit* secara umum dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan professional
- b. Setiap pemberi jasa pelayanan khususnya keperawatan dapat bekerja berdasarkan Visi, Misi, Falsafah, dan Tujuan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Prima Husada Malang

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1. Deskripsi RS Prima Husada

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Banjararum Selatan No 3 – 7 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 65153, Jawa Timur, Indonesia. Telp. 0341 – 458679, 458916, Fax: 0341 – 441874, email sekretariat@malang.rs-primahusada.com, website www.rs-primahusada.id.

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Manajer yaitu Manajer Pelayanan dan Manajer Keuangan dan Akuntansi dan Manajer Umum dan di dalam tugasnya dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian.

Rumah Sakit Prima Husada dengan pelayanan meliputi pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Kamar Operasi, Penunjang Medik, dan Penunjang Non Medik, serta Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari kelas I, II, III, VIP dan VVIP.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2. Sejarah Institusi RS Prima Husada

Berawal dari Praktek pribadi dr. Sadi Hariono, MMRS sebagai dokter umum sejak tahun 1990 di Banjararum Selatan No. 3B, kami telah mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada. Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan sebagai berikut :

Tahun 1990 – 2005	: Praktek Pribadi Dokter Umum
Tahun 2005 – 2009	: Balai Pengobatan Prima Husada
Agustus 2009	: Klinik Rawat Inap Layanan Medik Dasar
Mei 2010	: Menjadi Rumah Sakit Umum dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Tahun 2010 – 2014	: Izin Operasional Rumah Sakit Sementara
Februari 2015	: Izin Operasional Rumah Sakit Tetap
Februari 2016	: Penetapan Rumah Sakit Tipe C
Maret 2016	: Akreditasi Paripurna
Desember 2016	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Malang Raya Tahun 2016
April 2017	: Juara 1 Pelayanan dan Respon terbaik (Dinkes Kab. Malang)
Desember 2017	: Penghargaan Rumah Sakit Trauma Center terbaik se Jawa Timur Tahun 2017
Desember 2017	: Pengembangan Gedung DPM
Februari 2018	: Menjadi tempat dokter internsip
Maret 2020	: Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Covi19 di Jawa Timur (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur

BAB III

VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN

3.1. Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :
“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

3.2. Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberi pelayanan yang bermutu dengan berorientasi pada keselamatan dilandasi dengan hati yang penuh kasih pada sesama.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

3.3. Falsafah

Memberikan pelayanan secara professional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

3.4. Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

3.5. Tujuan

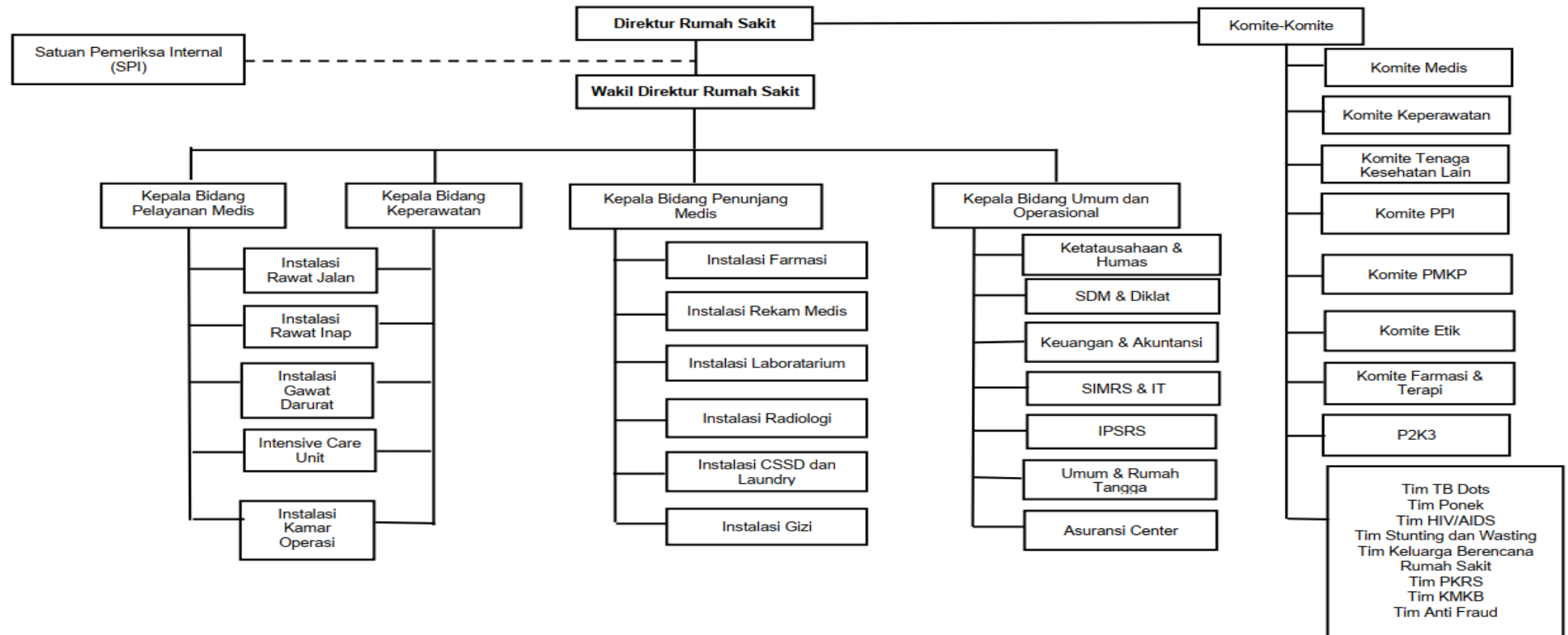
Rumah Sakit Prima Husada menjadi Rumah Sakit yang memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Malang dan sekitarnya.

3.6. Motto

“Sahabat Menuju Sehat”

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA

4.1 Bagan Organisasi



4.2. Keterangan / Pengertian

1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di RS Prima Husada.

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Kepala Bidang Penunjang Medik membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
- 3) Kepala Bidang Keperawatan membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit lebih khususnya pada bagian keperawatan
- 4) Kepala Bidang Operasional membantu Direktur dalam bagian :
 - a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia .
 - b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - c) Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tnagga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

c. Kepala Sub Bidang

Adalah pejabat yang membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Sub Bidang Keperawatan membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik dalam bidang Keperawatan.

d. Kepala Sub Bagian

Adalah pejabat yang membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing – masing yaitu :

- 1) Sub Bagian SDM membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait ketenagakerjaan Rumah Sakit
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Akutansi membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Keuangan dan Akutansi.
- 3) Sub Bagian Umum membantu Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugas terkait Sarana Prasaran Rumah Sakit, SIMRS, Security, Cleaning Service, Humas dan Pemasaran, Manajemen KOntrak dan Pengaduan Pelayanan

e. Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- 1) Kepala Instalasi Rawat Jalan
- 2) Kepala Instalasi Rawat Inap
- 3) Kepala *Intensive Care Unit*
- 4) Kepala *Neonatal Intensive Care Unit*
- 5) Kepala Instalasi Gawat Darurat
- 6) Kepala Instalasi Kamar Operasi
- 7) Kepala Instalasi Farmasi
- 8) Kepala Instalasi Rekam Medis
- 9) Kepala Unit Laboratorium
- 10) Kepala Unit Radiologi
- 11) Kepala Unit Gizi
- 12) Kepala Unit Laundry
- 13) Kepala Unit Kamar Jenazah
- 14) Kepala Unit Fisioterapi
- 15) Kepala Bagian SDM

-
- 16) Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi
 - 17) Kepala Bagian Umum

2. Unit Non Struktural

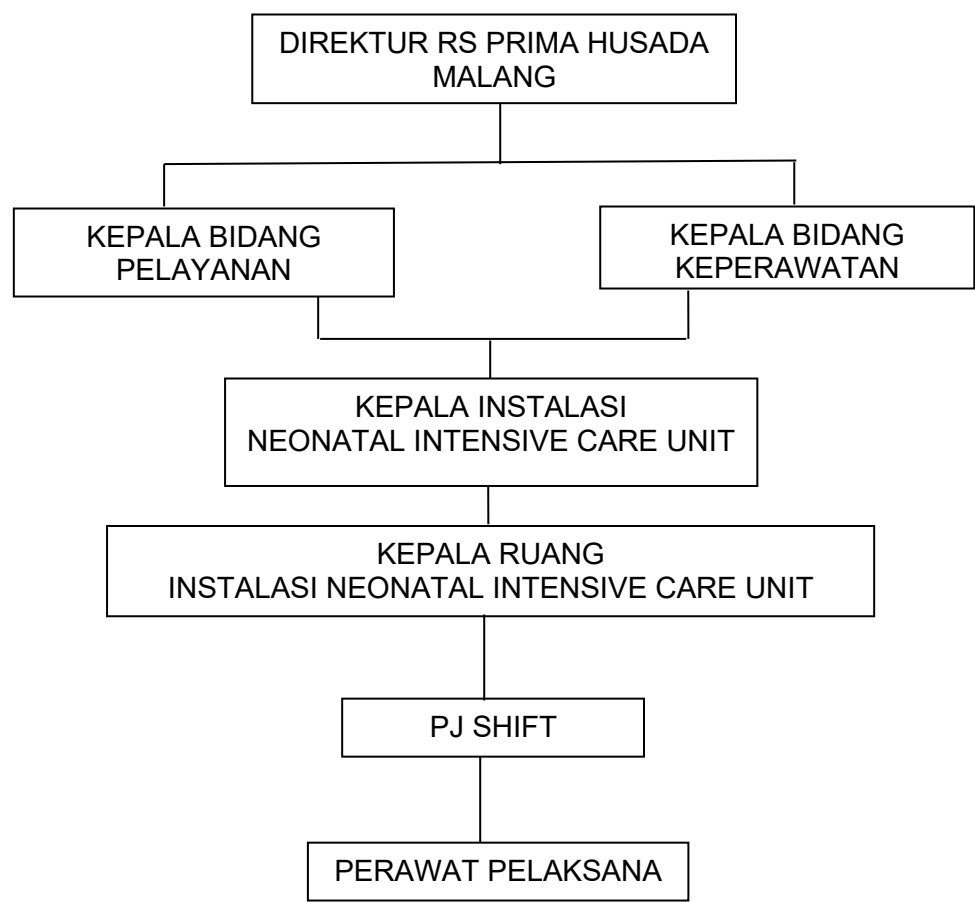
Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia / Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

- a. Komite Medik
- b. Komite Keperawatan
- c. Komite PPI
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Komite Etik
- f. Komite Farmasi & Terapi
- g. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- h. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
- i. Tim Rekam Medis
- j. Tim TB DOTS
- k. Tim PONEK
- l. Tim Geriatri
- m. Tim HIV
- n. Tim PKRS
- o. Tim Casemix

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI *NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT*

5.1. Struktur Organisasi Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit*



Gambar 5.1. Struktur Organisasi Instalasi *Neonatal Intensive Care Unit*

BAB VI

URAIAN JABATAN DAN TUGAS

6.1. Uraian Jabatan

1. Direktur RS Prima Husada
 - a. Mengetahui dan mematuhi semua perundang-undangan terkait dengan rumah sakit
 - b. Menjalankan operasional rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan standar akreditasi rumah sakit
 - c. Menetapkan regulasi rumah sakit
 - d. Memberikan arahan kebijakan rumah sakit
 - e. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya
 - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien selama dilayani di rumah sakit
 - g. Membuat dan menjalankan program kerja yang disusun dalam rencana strategis tahunan, rapat koordinasi, maupun forum lain
 - h. Membuat laporan penyelenggaraan operasional rumah sakit secara berkala
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Merencanakan kegiatan pelayanan medik meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, pelayanan kesehatan akibat bencana dan wabah serta pelayanan.
 - b. Merencanakan kebutuhan ketenagaan, pengembangan mutu layanan, pengembangan kualitas dan kompetensi petugas medik, peralatan dan sarana lainnya untuk pelayanan medis.
 - c. Menyusun, kebijakan teknis dan operasional, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan medik.
 - d. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan, petunjuk serta penilaian kinerja untuk mengangkat profesionalisme dan kelancaran tugas
 - e. Mengatur pelaksanaan pelayanan medik paripurna bagi pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif serta berkoordinasi dengan kabinid pelayanan penunjang.
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu pelayanan medik
 - h. Mengadakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
 - i. Menyusun laporan secara periodik baik lisan maupun tertulis guna pertanggung jawaban pelaksanaan tugas bidang pelayanan medik.
 - j. Melakukan koordinasi wakil direktur dan direktur.
 - k. Melakukan koordinasi dengan komite medik.
3. Kepala Bidang Keperawatan
 - a. Merencanakan jumlah dan kategori tenaga keperawatan sesuai kebutuhan.
 - b. Merencanakan jumlah dan jenis peralatan keperawatan yang dibutuhkan di unit perawatan sesuai kebutuhan.
 - c. Merencanakan dan menentukan jenis kegiatan/ asuhan keperawatan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan pasien.
 - d. Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan.
 - e. Melaksanakan program orientasi kepada staf perawat baru yang akan bekerja.
 - f. Memberi pengarahan dan motivasi kepada staf keperawatan untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai ketentuan/standar
 - g. Mengadakan pertemuan berkala dengan pelaksana perawatan.
 - h. Mengenal jenis dan kegunaan barang/peralatan serta mengusahakan pengadaannya sesuai kebutuhan pasien agar tercapai pelayanan optimal.
 - i. Menyusun permintaan rutin meliputi kebutuhan alat, obat dan bahan lain yang diperlukan.
 - j. Mengatur dan mengkoordinasi pemeliharaan peralatan agar selalu dalam keadaan siap pakai.

-
- k. Memelihara dan mengembangkan system pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kegiatan lain yang dilakukan secara tetap dan benar.
 - l. Mengadakan kerjasama yang baik dengan kepala unit lain, kepala bidang dan kepala bagian lain.
 - m. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara petugas, pasien dan keluarganya.
 - n. Membuat laporan bulanan mengenai pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan serta kegiatan lain
 - o. Mengawasi dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan.
 - p. Melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan, pengetahuan dan keterampilan di bidang perawatan.
4. Kepala Instalasi Rawat Inap
- a. Membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Keperawatan dalam bidang teknis fungsional pada instalasi rawat inap
 - b. Melaksanakan pelayanan selama 24 jam dalam rangka penanganan pasien rawat inap
 - c. Melakukan pelayanan diagnostic, tindakan dan pengobatan rawat inap
 - d. Menyusun program, mengatur dan mengawasi kebutuhan pelayanan tindakan rawat inap
 - e. Membuat prosedur tetap pelayanan pada setiap jenis tindakan medis
 - f. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berkala
 - g. Berkolaborasi dengan profesi medis untuk tindakan-tindakan medis
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur rumah sakit
5. Kepala Ruang Rawat Inap
- a. Menyusun rencana kerja
 - b. Berperan serta menyusun visis, misi, falsafah, tujuan keperawatan dan tujuan khusus ruang keperawatan'menyusun rencana kebutuhan staf perawat dari segi jumlah maupun kualifikasi untuk diruang rawat
 - c. Mengatur dan mengkondisikan seluruh kegiatan pelayanan di ruang perawatan melalui kerjasama dengan staf lain
 - d. Menyusun jadwal dan daftar dinas staf perawat
 - e. Melaksanakan orientasi kepada staf baru
 - f. Membimbing staf perawat untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar
 - g. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan keperawatan/ kebidanan
 - h. Mendelegasikan tugas kepada setiap stafnya
 - i. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan
 - j. Melakukan penilaian kinerja perawat yang berada dibawah tanggung jawabnya
 - k. Mengawasi dan menilai pendayagunaan staf perawat, eralatan dan obat-obatan
 - l. Mengawasi dan menilai mutu asuhan keperawatan sesuai standar yang berlaku secara mandiri.
6. Perawat Kepala Jaga/ Ka Shift
- a. Membuat tujuan dan rencana keperawatan'melaksanakan rencana yang telah dibuat sekama praktek bila diperlukan
 - b. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh disiplin ilmu lain maupun keperawatan
 - c. Mengevaluasi keberhasilan asuhan keperawatan
 - d. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh disiplin lain
 - e. Mengevaluasi keberhasilan yang dicapai
 - f. Menyiapkan penyuluhan untuk pulang
 - g. Melakukan pengelolaan rujukan antar rumah sakit
 - h. Mendampingi visite dokter spesialis
 - i. Melaksanakan ronde keperawatan bersama dengan kepala ruangan dan

-
- perawat associate
 - j. Melaporkan perkembangan pasien kepada dokter penanggung jawab (DPJP)
 - k. Menuliskan asuhan keperawatan pada catatan terintegrasi (CPPT)
 - l. Menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif
 - m. Mengecek kebenaran jumlah kemasan obat, kondisi kemasan obat seperti yang disyaratkan, jumlah satuan dalam tiap kemasan, kebenaran identitas produk, jangka waktu kadaluarsa, dan jenis produk yang diterima sebelum diberikan ke pasien
 - n. Melakukan penerimaan rujukan dari instalasi lain
7. Perawat Pelaksana
- a. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan instalasi rawat inap untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien untuk menerima pelayanan
 - b. Menerima pasien baru sesuai dengan prosedur dan kebijakan berlaku
 - c. Melaksanakan tehnik septik dan aseptik
 - d. Memelihara peralatan keperawatan/ medis agar selalu dalam keadaan siap pakai
 - e. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarganya
 - f. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien dalam rangka memberikan askep dengan cara :
 - 1) Mengamati keadaan pasien (tanda vital, kesadaran, keadaan mental, dan keluhan utama, airway dan sirkulasi)
 - 2) Melaksanakan anamnesa secara cermat dan pemeriksaan fisik sesuai dengan wewenangnya
 - 3) Menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai dengan prioritas masalah
 - 4) Memberikan pertolongan basic life support (resusitasi kardiopulmoner)
 - g. Memberikan pelayanan dasar kepada pasien sesuai kebutuhan dengan cara :
 - 1) Memberikan rasa aman kepada pasien yang meliputi : mencegah terjadinya bahaya kecelakaan, luka, gangguan pernafasan. (bila perlu memerlukan alat bantu pernafasan), komplikasi, khususnya pada pasien yang mengalami gangguan kesadaran
 - 2) Melaksanakan tindakan pengobatan sesuai program terapi
 - 3) Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya, mengenai penyakitnya sesuai batas kewenangannya
 - h. Membantu merujuk pasien kepada petugas kesehatan atau institusi pelayanan lain yang lebih mampu untuk menangani/ memenuhi kebutuhan kesehatan/ menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi
 - i. Melakukan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat secara tepat dan benar sesuai kebutuhan secara tepat dan benar sesuai kebutuhan serta merujuk yang berlaku
 - j. Selanjutnya segera melaporkan tindakan yang telah dilakukan, kepada dokter penanggung jawab (DPJP)
 - k. Melaksanakan evaluasi tindakan asuhan keperawatan dan selanjutnya melakukan tindakan yang tepat sesuai hasil pemantauan
 - l. Membantu petugas lain dalam memelihara lingkungan yang sehat
 - m. Menciptakan hubungan kerja yang baik dengan anggota tim kesehatan lain (dokter, ahli gizi, analis, farmasi, dll) di instalasi rawat inap
 - n. Melaksanakan tugas pagi, sore, malam, dan hari libur secara bergilir sesuai dengan jadwal dinas
 - o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara petugas, pasien, dan keluarganya, sehingga terciptanya ketenangan
 - p. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang perawatan, misal : melalui pertemuan ilmiah, seminar, pelatihan-pelatihan di bidang keperawatan maupun medis
 - q. Melaksanakan dan memelihara system pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan secara tepat dan benar, sehingga tercipta suatu system informasi rumah sakit yang dapat dipercaya dan akurat

- r. Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti, baik secara lisan atau tertulis pada saat pergantian dinas
- s. Melaksanakan perawatan pasien dalam keadaan sakaratul maut dan merawat jenazah sesuai dengan prosedur yang berlaku
- t. Memegang teguh rahasia jabatan
- u. Melaksanakan program pendampingan pastoral/ kesehatan holistic dan program lain yang telah ditetapkan sebagai program rumah sakit
- v. Melaksanakan tindakan perawatan yang telah disusun
- w. Mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah diberikan
- x. Mencatat dan melaporkan semua tindakan perawatan dan respon klien pada catatan perawatan
- y. Mengecek kebenaran jumlah kemasan obat. Kondisi kemasan obat seperti yang diisyaratkan, jumlah satuan dalam tiap kemasan, kebenaran identitas produk, jangka waktu kadaluarsa, dan jenis produk yang diterima sebelum diberikan ke pasien
- z. Mempersiapkan pasien operasi, benar nama pasien, diagnosis, jenis tindakan dan kelengkapan hasil penunjang
 - aa. Menyiapkan obat dan tindakan yang akan diberikan kepada pasien
 - bb. Memelihara kebersihan pasien dan lingkungan
 - cc. Melakukan pendekatan komunikasi terapeutik
 - dd. Mengurangi penderitaan pasien dengan memberi rasa aman, nyaman, dan ketenangan
 - ee. Melakukan asesmen nyeri pada pasien
 - ff. Melakukan sensus harian dan formulir

6.2. Tanggung Jawab

1. Direktur RS Prima Husada
 - a. Menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap perundang-undangan
 - b. Menetapkan proses untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Menilai dan menyetujui rencana anggaran
 - d. Menjalankan visi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemilik
 - e. Menjamin dicapainya akreditasi rumah sakit dengan predikat paripurna
 - f. Menjamin tercapainya peningkatan dana, pelayanan dan kinerja keuangan rumah sakit setiap tahun
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Bertanggung jawab kegiatan pelaksanaan pelayanan medis ke wakil direktur dan direktur
 - b. Bertanggung jawab pada mutu pelayanan medis yang efektif dan efisien
 - c. Bertanggung jawab pada kebijakan yang telah disusun
 - d. Bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis
 - e. Bertanggung jawab pada monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
 - f. Bertanggung jawab pada mutu dan keselamatan pasien
 - g. Melaporkan hasil kinerja kepada Direktur Rumah Sakit
3. Kepala Bidang Keperawatan
 - a. Pemenuhan kebutuhan staf perawat di unit perawatan.
 - b. Kelengkapan asuhan keperawatan.
 - c. Bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan dan penunjang medis
4. Kepala Instalasi Rawat Inap
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis
 - b. Membantu dalam menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit
 - c. Menetapkan pembagian pekerjaan, Batasan tugas, tanggung jawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas
5. Kepala Ruang Rawat Inap

-
- a. Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan staf perawat dan bidan
 - b. Kebenaran dan ketepatan pengembangan pelayanan keperawatan/ kebidanan
 - c. Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja perawat dan bidan
 - d. Kelancaran kegiatan perawat dan bidan baru
 - e. Kebenaran dan ketepatan protap SPO pelayanan keperawatan/ kebidanan
6. Perawat Kepala Jaga/ Ka Shift
- a. Mengawasi pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan
 - b. Mengawasi pelaksanaan system pencatatan dan pelaporan kegiatan asuhan keperawatan serta mencatat kegiatan lain di ruang rawat inap
 - c. Mengawasi pendayagunaan peralatan perawatan serta obat-obatan secara efektif dan efisien
 - d. Menjaga penerapan kode etik asuhan keperawatan dalam praktik sehari-hari
 - e. Menerapkan pertimbangan professional dalam melakukan praktik keperawatan dengan mengindahkan kode etik dan disiplin
 - f. Menjelaskan ketentuan perundang-undangan bidan keperawatan secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum , dan penerapannya dalam praktik
7. Perawat Pelaksana
- a. Secara administrasi dan fungsional bertanggung jawab kepada kepala instalasi rawat inap
 - b. Secara teknis medis operasional, bertanggung jawab kepada dokter di instalasi rawat inap.
 - c. Menjaga penerapan kode etik asuhan keperawatan dalam praktik sehari-hari
 - d. Menerapkan pertimbangan professional dalam melakukan praktik keperawatan dengan mengindahkan kode etik dan disiplin
 - e. Menjelaskan ketentuan perundangan bidang keperawatan secara khusus dan ketentuan bidang kesehatan secara umum, dan penerapannya dalam praktik

6.3. Wewenang

1. Direktur RS Prima Husada
 - a. Menindaklanjuti terhadap semua laporan hasil pemeriksaan badan audit internal maupun eksternal
 - b. Menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi semua regulasi rumah sakit yang telah ditetapkan dan disepakati Bersama
 - c. Menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit
 - d. Mengelola dan melakukan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan rumah sakit sesuai dengan pola ketenagaan dan pengembangan pelayanan
 - e. Menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - a. Berwenang melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan medik
 - b. Berwenang dalam Menyusun, kebijakan teknis dan operasional, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan medik
 - c. Berwenang dalam mengatur pelaksanaan mutu pelayanan medis
3. Kepala Bidang Keperawatan
 - a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan.
 - b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan staf keperawatan.
 - c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf keperawatan, peralatan dan mutu asuhan keperawatan.
 - a. Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang kepala sub bidang keperawatan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan keperawatan

-
4. Kepala Instalasi Rawat Inap
 - a. Menyusun rencana operasi di instalasi rawat inap
 - b. Mengorganisir sumber daya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instalasi rawat inap
 - c. Melakukan supervisi terhadap SDM di lingkungan instalasi rawat inap
 - d. Membuat usulan kebutuhan yang diperlukan di instalasi rawat inap
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidangnya
 5. Kepala Ruang Rawat Inap
 - a. Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan
 - b. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas dan staf keperawatan dan kebidanan
 - c. Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf keperawatan/kebidanan, peralatan dan mutu asuhan keperawatan di ruang perawatan
 - d. Menandatangani surat dan dokumen yang menjadi wewenang kepala ruangan
 - e. Menghadiri rapat dan pertemuan berkala
 6. Perawat Kepala Jaga/ Ka Shift
 - a. Melaksanakan penilaian terhadap upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang perawatan
 - b. Menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan
 - c. Menilai pendayagunaan peralatan perawatan serta obat-obatan secara efektif dan efisien
 - d. Menilai tugas dan tanggung jawab perawat pelaksana
 - e. Menilai pendayagunaan peralatan perawatan serta obat-obatan secara efektif dan efisien
 - f. Mengendalikan pendayagunaan peralatan perawatan serta obat-obatan secara efektif dan efisien
 - g. Mengendalikan system pencatatan dan pelaporan kegiatan asuhan keperawatan serta mencatat kegiatan lain di ruang rawat inap
 7. Perawat Pelaksana
 - a. Mengatur dan menyiapkan alat-alat yang ada di ruangan
 - b. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, dan kenyamanan
 - c. Melaporkan segala sesuatu mengenai keadaan klien baik lisan maupun tertulis
 - d. Melakukan observasi tanda-tanda vital setiap shift maupun pada setiap pasien yang mengalami perubahan kondisi

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

7.1. Tata Hubungan Kerja



Gambar 7.1. Tata Hubungan Kerja

7.2. Pola Hubungan Pelayanan

1. Hubungan kerja dengan Direktur :
 - Pelaporan dari Instalasi NICU tentang seluruh kegiatan yang dilakukan bagian masing-masing.
 - Berkoordinasi bersama-sama mencari solusi berkaitan dengan masalah yang terjadi di Instalasi NICU
2. Hubungan kerja dengan Instalasi Farmasi
 - Sebagai penyedia obat dan alkes dengan menggunakan resep sesuai SPO
 - Berkoordinasi tentang Supervisi Box Emergensi (Emergency Kit)
 - Melakukan verifikasi perhitungan dosis yang sangat kecil agar tidak terjadi kelebihan dosis (overdose).
3. Hubungan kerja dengan laboratorium
 - Penegakan diagnose dengan pemeriksaan laboratorium menggunakan billing laboratorium
 - Berkoordinasi dalam pengambilan dan pengiriman sampel darah tumit bayi untuk program skrining nasional (SHK)
 - Penyedia komponen darah yang sesuai dengan golongan darah bayi dan ibu jika bayi membutuhkan transfusi (seperti PRC atau Fresh Frozen Plasma), laboratorium/Bank Darah bertanggung jawab melakukan uji silang (cross-match) dan Hubungan kerja dengan Radiologi
4. Hubungan kerja dengan Radiologi
 - Penegakan diagnose dengan pemeriksaan radiologi menggunakan billing pemeriksaan radiologi
 - Menyediakan alat X-Ray portabel yang dibawa langsung ke dalam ruang NICU.
 - Berkoordinasi dengan perawat NICU untuk memastikan penggunaan apron (pelindung timbal) bagi petugas dan memastikan bayi lain di sekitar area pemeriksaan terlindungi dari paparan radiasi.

- Melakukan desinfeksi pada kaset X-Ray dan perangkat alat sebelum bersentuhan dengan lingkungan inkubator bayi untuk mencegah infeksi silang.
5. Hubungan kerja dengan Instalasi Gizi
- Manajemen Laktasi : Instalasi Gizi (ahli gizi) bekerja sama dengan perawat NICU untuk memberikan edukasi kepada ibu bayi mengenai teknik pemerah ASI (Manajemen Laktasi).
 - Fortifikasi ASI : Jika bayi prematur membutuhkan kalori lebih tinggi, ahli gizi menyediakan bahan fortifikasi (HMF - Human Milk Fortifier) untuk dicampurkan ke dalam ASI sesuai instruksi dokter.
 - Dapur Susu (Milk Kitchen): Hubungan operasional dalam penyiapan susu formula dalam kondisi steril di ruang penyiapan nutrisi instalasi gizi, yang kemudian didistribusikan ke unit NICU dalam kemasan sekali pakai yang berlabel identitas pasien.
6. Hubungan kerja dengan IGD
- Melakukan triase awal. Jika bayi dalam kondisi kritis (misal: gagal napas atau kejang), IGD segera menghubungi NICU untuk menyiapkan tempat dan peralatan (ventilator/CPAP).
 - Berkoordinasi dalam Tim Resusitasi : Dalam kasus bayi lahir mati atau asfiksia berat yang datang ke IGD, perawat atau dokter NICU dapat dipanggil ke IGD untuk membantu proses resusitasi neonatus menggunakan T-Piece Resuscitator atau Bag-Valve-Mask.
 - Stabilisasi Sebelum Transfer: IGD bertanggung jawab menstabilkan suhu (mencegah hipotermia) dan jalan napas sebelum bayi dipindahkan ke NICU menggunakan Transport Incubator.
7. Hubungan kerja dengan IRJA
- Berkoordinasi Klinik Tumbuh Kembang : Bayi pasca - rawat NICU wajib dijadwalkan kontrol ke Poli Anak atau Klinik Tumbuh Kembang di IRJA untuk memantau efek samping prematuritas (seperti gangguan motorik atau kognitif).
 - Berkoordinasi untuk skrining lanjutan, misalnya pemeriksaan ROP (Retinopathy of Prematurity) atau tes pendengaran (OAE/BERA) yang dilakukan secara rawat jalan setelah bayi pulang.
8. Hubungan Kerja dengan Instalasi Kamar Operasi
- Koordinasi Pre-Operatif: Bagian Kamar Operasi wajib memberikan informasi kepada NICU jika ada jadwal operasi persalinan dengan risiko tinggi (misalnya: bayi prematur, gawat janin, atau kelainan kongenital).
 - Penyediaan Sarana: Kamar Operasi menyediakan area khusus resusitasi yang dilengkapi dengan Infant Warmer, oksigen sentral, dan suction. NICU bertanggung jawab memastikan alat-alat tersebut berfungsi (melalui supervisi berkala) atau membawa peralatan tambahan jika diperlukan.
 - Tindakan Life-Saving: Tim NICU melakukan tindakan stabilisasi segera setelah bayi lahir di meja operasi sebelum bayi dipindahkan ke ruang intensif.
9. Hubungan Kerja dengan Instalasi Maternal
- Pada persalinan berisiko, tim NICU hadir di Kamar Bersalin sebelum bayi lahir untuk menyiapkan alat resusitasi dan memberikan pertolongan pertama segera setelah pemotongan tali pusat.
 - Berkoordinasi dalam memfasilitasi IMD jika kondisi bayi stabil. Jika bayi harus masuk NICU, kedua unit bekerja sama membantu ibu melakukan pompa ASI sedini mungkin (dalam 1-2 jam pasca salin).
 - Serah Terima (Handover) : Dokumentasi serah terima dilakukan menggunakan formulir terintegrasi yang mencakup data kelahiran (jam lahir, Skor APGAR, berat lahir, panjang badan) dan tindakan yang sudah diberikan di Kamar Bersalin (seperti Injeksi Vitamin K dan Salep Mata).
 - Melakukan pertemuan audit medis bersama untuk mengevaluasi kronologis penanganan sejak bayi dalam kandungan hingga pasca salin demi perbaikan mutu pelayanan ke depan.
10. Hubungan kerja dengan Laundry dan CSSD
- Berkoordinasi berkaitan dengan pencucian dan penyeterilan peralatan penerimaan bayi baru lahir (selang penghubung suction, gunting tali pusat)

- Linen bekas pakai yang terkena cairan tubuh bayi dikirim ke laundry dengan prosedur khusus (infeksius).

11. Hubungan Kerja dengan PIPP/Humas/PKRS:

- Mediator untuk menyelesaikan masalah Jika terdapat ketidakpuasan keluarga terkait pelayanan atau komunikasi medis di NICU
- Humas membantu memberikan informasi umum mengenai fasilitas NICU dan estimasi biaya (terutama bagi pasien umum)
- PKRS membantu memfasilitasi penyuluhan rutin bagi orang tua bayi di ruang tunggu NICU, seperti edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif, metode Kanguru, atau teknik cuci tangan yang benar sebelum masuk area NICU.
- PKRS bertanggung jawab menyediakan sarana edukasi visual seperti leaflet, poster, atau video instruksional di area NICU mengenai perawatan bayi prematur dan pencegahan infeksi.

12. Hubungan Kerja dengan Instalasi Rekam Medis:

- Berkoordinasi berkaitan penyimpanan, pengelolaan, penyajian data rekam medis secara lengkap, akurat, dan aman.
- Petugas Rekam Medis dapat mengeluarkan dokumen kematian seperti Surat Keterangan Kematian atau Laporan ringkasan kematian (resume medis) jika di kemudian hari keluarga jenazah membutuhkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

13. Hubungan Kerja dengan Administrasi/Keuangan/Kasir:

- Berkoordinasi berkaitan dengan pelunasan biaya perawatan

14. Hubungan kerja dengan Security:

- Berkoordinasi berkaitan dengan keamanan ketertiban, dan pengawasan di seluruh area rumah sakit.
- Melakukan pengamanan untuk pencegahan penculikan bayi
- Mengatur akses keluar-masuk pihak luar, termasuk keluarga jenazah atau pihak kepolisian.

BAB VIII

POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

Dalam upaya mempersiapkan tenaga medis Neonatal intensive care unit yang handal perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan dan mempertahankan sumber daya manusia yang tepat. Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan SDM, yaitu proses mengantisipasi dan

menyiapkan tenaga dengan kualifikasi sesuai standar. Tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan, kualifikasi Pendidikan, sertifikat khusus, pengalaman kerja. Perencanaan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai sasarannya melalui strategi pengembangan kontribusi acuan yang digunakan menggunakan perhitungan Depkes 2005.

8.1. Tabel Perhitungan Pola Ketenagaan

a. Tingkat ketergantungan pasien

No	Kategori	Rata jumlah Px/hari	Jumlah jam perawatan/hari	Jumlah jam perawatan/hari
1	Askep Minimal	0	2	0
2	Askep Sedang	0	3,08	0
3	Askep Berat	4	4,15	16,6
4	Askep Maksimal	4	6,16	24,64
	Jumlah	8		41,24

b. Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan yang diperlukan/hari}}{\text{Jam Kerja efektif/shift 7}} : 41,24 = 5,89$$

c. Koreksi Loss Day

$$\frac{\text{Jumlah Hari Non Efektif (Hari Libur/Cuti/hari Besar)} \times \text{Jumlah Perawat yang Dibutuhkan}}{\text{Jumlah hari kerja efektif}}$$

$$= \frac{(52+12+14)}{286} \times 5,89$$

$$= \frac{78 \times 5,89}{286} = \frac{459,4}{286} = 1,6$$

d. Tugas Non Keperawatan 25%

$$\frac{\text{Jumlah perawat yang dibutuhkan} + \text{loss day} \times 25}{100}$$

$$= \frac{5,89 + 1,6 \times 25}{100}$$

$$= \frac{187,25}{100}$$

$$= 1,9$$

e. Jumlah tenaga yang dibutuhkan

$$5,89 + 1,6 + 1,9 = 9 \text{ orang}$$

Jumlah tenaga di NICU saat ini berjumlah 8 orang

8.2. Kualifikasi Staf

Table 8.1. Kualifikasi Staf

NO	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN	KUALIFIKASI	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1	Kepala	Dokter	Sertifikat yang	1	0

	Instalasi NICU	spesialis Anak	mendukung di bidangnya 1. Resusitasi Neonatus (Pelatihan Lanjut), 2. Pelatihan Manajemen Unit Intensif/NICU 3. Sertifikat kompetensi yang masih berlaku (STR & SIP)		
2	Kepala Ruang NICU	S1 Keperawatan + Ners	Sertifikat yang mendukung di bidangnya 1. Pelatihan Manajemen Bangsal/Kepala Ruangan 2. Pelatihan NICU Level II atau Level III (Sertifikat Nasional) 3. Resusitasi Neonatus 4. STR 5. SIP 6. BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support)	1	0
3	Kepala Jaga/ Penanggung Jawab Shif	S1 Keperawatan + Ners D4 Keperawatan/ Kebidanan D3 Keperawatan/ Kebidanan	Sertifikat yang mendukung di Bidanganya 1. Resusitasi Neonatus 2. Manajemen Laktasi 3. Pelatihan K3RS & Patient Safety 4. Jenjang Karir (Klinik): Minimal berada pada level Perawat Klinik II (PK II) 5. STR 6. SIP 7. BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support)	3	1
4	Perawat Pelaksana	S1 Keperawatan + Ners D4	Sertifikat yang mendukung di bidangnya 1. Resusitasi	4	0

		Keperawatan/ Kebidanan D3 Keperawatan/ Kebidanan	Neonatus 2. BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) 3. Kompetensi Teknis Khusus (Skill Set)		
--	--	--	--	--	--

8.3. Penempatan dan Penempatan Kembali Staf

Perencanaan kebutuhan yang tepat dengan jumlah yang mencukupi adalah hal yang sangat penting bagi asuhan pasien termasuk keterlibatan rumah sakit dalam semua kegiatan pendidikan dan riset. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi.

Pimpinan unit layanan membuat rencana pola ketenagaan dengan menggunakan proses yang sudah diakui untuk menentukan jenjang kepegawaian. Perencanaan kepegawaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penempatan kembali dari satu unit layanan ke lain unit layanan karena alasan kompetensi, kebutuhan pasien, atau kekurangan staf;
 - a. Staf yang mempunyai kompetensi tambahan seperti pelatihan Instrumen, pelatihan Kegawatdaruratan Neonatus, Pelatihan ICU dasar, Pelatihan Anestesi tidak dapat dirotasi ke unit lain dikarenakan terdapat unit prioritas yang khusus membutuhkan kompetensi tambahan tersebut. Misalnya Staf yang memiliki pelatihanInstrumen, ditempatkan di Instalasi Kamar operasi, sebaliknya staf yang mempunyai kompetensi ICU dasar di tempatkan di *Instalasi Care Unit* (ICU)
 - b. Penempatan staf dapat dilakukan apabila dalam unit tersebut terdapat kebutuhan mendesak sedangkan staf yang dibutuhkan belum tersedia, maka staf tersebut di rotasi sementara untuk menjagastabilitas pelayanan dengan tetap memperhatikan kualifikasi dan Rincian Kewenangan Klinis yang sesuai.
2. Mempertimbangkan keinginan staf untuk ditempatkan kembali karena alasan nilai-nilai, kepercayaan, dan agama. Mengkaji keinginan staf untuk ditempatkan pada unit yang sesuai berdasarkan hasil psikotest, menggali nilai kepribadian staf apakah lebih berpotensi pada unit pelayanan atau manajemen, atau bahkan marketing yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
3. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan (*placement*) atau penempatan kembali (*replacement*) harus memperhatikan faktor kompetensi, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis yang telah disetujui Direktur RS Prima Husada dengan tetap mengacu pada peraturan perundan-undangan yang berlaku. Setiap staf mempunyai tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya. Dalam hal ini kompetensi dan kewenangan menjadi dasar dalam menentukan penempatan, uraian pekerjaan, dan kriteria untuk evaluasi kinerja staf. Uraian tugas juga diperlukan untuk tenaga kesehatan profesional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Staf yang bekerja terutama di bidang manajemen dan fungsional. Contoh, dokter spesialis bedah merangkap sebagai Kepala Instalasi Kamar Operasi dan sebagai dokter bedah harus mempunyai STR, SIP, SPK, RKK dan sebagai kepala instalasi kamar operasi mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - b. Seseorang dalam program pendidikan dan bekerja di bawah supervisi maka program pendidikan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan tingkat pendidikannya;

Bagi mereka yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan praktik mandiri harus dilakukan proses untuk identifikasi dan memberikan wewenang melaksanakan praktik dengan dasar latar belakang pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman. Persyaratan standar ini berlaku untuk semua jenis staf yang harus ada uraian tugasnya. (contoh, penugasan penuh

waktu, paruh waktu, dipekerjakan, sukarela, sementara.

8.4. Evaluasi Dan Pemutakhiran Staf

1. Pemutakhiran dan evaluasi staf dilakukan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan tiap bulan di laporan bulanan
2. Dihadiri oleh Direktur, Kepala Bidang, kepala Unit, dan SDM
3. Setiap ada staf yang melakukan pengunduran diri
4. Setiap penambahan jenis pelayanan, jumlah pasien dan jumlah alat yang mempengaruhi perhitungan awal pola ketenagaan

8.5 Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Instalasi NICU memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawan dilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat dibagi dua yaitu:

1. Dari dalam Rumah Sakit Prima Husada sendiri (*internal resources*)
Menarik calon dari dalam RS Prima Husada sendiri (*Internal resources*) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah dikenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dibanding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas-berkas pelamar yang masuk ke rumah sakit Prima Husada
2. Dari luar RS. Prima Husada (*external resources*)
Proses penarikan calon dari luar RS. Prima Husada ini dapat dilakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Seleksi adalah bagian yang terpenting dalam rekrutmen tenaga kerja, dilakukan berdasarkan persyaratan jabatan. Sistem seleksi perawat baru di bidang keperawatan berdasarkan :

1. Latar Belakang Pendidikan : D3 / D4 / S1 Keperawatan atau Kebidanan
2. Diutamakan yang memiliki pengalaman kerja
3. IPK diatas 2,80
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Menguasai Asuhan Keperawatan / Kebidanan
6. Usia maksimal 35 tahun
7. Mudah bekerja secara mandiri atau tim
8. Hasil tes tulis dan uji kompetensi / prosedur keperawatan baik
9. Hasil tes psikology baik
10. Hasil Wawancara baik
11. Hasil Test Kesehatan baik

8.6. Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Instalasi NICU khususnya dan Rumah Sakit Prima Husada umumnya, diperlukan pembinaan/pengembangan kompetensi tenaga perawat. Pembinaan/ pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan tugas dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Pendidikan
Tenaga dengan pendidikan setingkat SMA diberi ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan DIII, dst.
2. Pelatihan
Pelatihan untuk peningkatan kompetensi perawat dan bidan di Instalasi NICU

dilaksanakan melalui :

- a. *Internal Training* yaitu program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan PPI dasar dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD.
- b. *External Training* yaitu program pelatihan diluar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Instalasi NICU.

BAB IX
KEGIATAN ORIENTASI

Tabel 9.1 Kegiatan Orientasi

MINGGU/ HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
Minggu I Hari ke I - III	1. Tujuan orientasi, sejarah, visi, misi, motto RSPH, struktur organisasi RSPH 2. Peraturan kepegawaian/ KKB 3. Service excellent 4. Fasilitas, sarana, produk-produk RSPH 5. Kebijakan pasien rekanan 6. Etika dan Hukum (umum dan keperawatan) 7. Uraian tugas perawat pelaksana 8. Perencanaan pasien pulang/ discharge planning 9. Alur dan prosedur penerimaan pasien baru rawat inap dan rawat jalan 10. Alur dan tata laksana pemeriksaan penunjang medis, farmasi, gizi 11. Pencegahan infeksi nosocomial 12. Penjelasan tentang format yang ada di dalam keperawatan dan latihan pengisian format-format dalam keperawatan 13. Latihan dalam pengisian RM dan penginputan SIMRS 14. Latihan BHD dasar	8 jam	Cerama Diskusi	SDM
Hari ke IV - VI	1. Pelaksanan asuhan keperawatan dan metode penugasan 2. Sosialisasi SPO keperawatan (12 kor kompetensi dasar) 3. Etik dan Mutu Disiplin Keperawatan 4. Orientasi ruangan, penjelasan format-format penilaian	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan
Minggu ke II	1. Mengenal sistem dokumentasi keperawatan, format-format dokumen keperawatan, metode penugasan 2. Mengenal peralatan dan fasilitas seperti EKG, oksigen, suction 3. Mengenal dan melakukan memandikan pasien baru 4. Mengenal dan melakukan penerimaan pasien baru 5. Mengganti alat tenundengan dan tanpa pasien diatasnya 6. Membantu pasienmakan 7. Menolong buang air kecil dan besar ditempat tidur dan kamar mandi 8. Mengenal pengambilan bahan pemeriksaan urin dan faeces 9. Memberikan pasien posisi semi fowler 10. Memindahkan pasiendari tempat	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap

	tidur ke kursi roda/ kereta dorong 11. Mengenal dan menyiapkan obat-obatal dan injeksi 12. Mengenal cara-cara tindakan injeksi IM/ IV/ SC/ IC, obat oral/supp, inhalasi, NGT, Dower Catheter, perawatan luka dengan didampingi CI/ perseptor lapangan			
Minggu ke III	1. Mengenal dan melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien 2. Mengenal peralatan dan fasilitas seperti nebulizer, monitor, syringepump, infuspump, ripple bed, blood warmer 3. Mengenal dan melakukan prosedur-prosedur pemeriksaan penunjang, antara lain: resep, laboratorium, diagnostik lain 4. Mengenal dokter-dokter yang merawat di ruangan 5. Mengenal dan melakukan perawatan jenazah 6. Mengajarkan latihan nafas dalam dan batuk efektif 7. Mengenal cara pemasangan infus 8. Mengenal dan melaksanakan prosedur pre/ post operasi didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 9. Mengenal cara-cara menghubungi dokter via telephone dan cara mengikuti dokter visite didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 10. Mampu menggunakan peralatan dan fasilitas dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap
Minggu ke IV	1. Pengenalan pencegahan nosokomial (ICN di ruangan) 2. Melakukan dokumentasi keperawatan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ, meliputi: a. Pengisian pengkajian keperawatan meliputi perkembangan keperawatan b. Format penerimaan pasien baru, pasien pulang, pindah ruangan dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 3. Mengenal dan melaksanakan prosedur pre/post operasi didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 4. Mengenal cara-cara menghubungi dokter via telephone dan cara mengikuti dokter visite didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 5. Mampu menggunakan peralatan dan fasilitas dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap

Minggu ke V	1. Menenal dan melakukan konsul internal dan eksternal dokter spesialis RSPH 2. Menyiapkan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan penunjang mandiri meliputi: laboratorium, radiologi, diagnostik lain, resep, dll 3. Melakukan dokumentasi keperawatan mandiri, meliputi: a. Pengisian pengkajian keperawatan meliputi perkembangan keperawatan b. Format penerimaan pasien baru, pasien pulang, pindah ruangan 4. Melakukan penggunaan peralatan dan fasilitas EKG, Suction secara mandiri 5. Melakukan perawatan Hygiene, menerima pasien baru, pengkajian secara mandiri 6. Mengganti alat tenun dengan pasien atau tanpa pasien diatasnya, membantu pasien makan dan menolong buang air kecil dan besar secara mandiri 7. Mampu mengambil bahan untuk pemeriksaan urin dan faeces serta mengirimnya ke laboratorium	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap
Minggu ke VI	1. Melakukan tindakan injeksi IV/ IM/ SC/ IC, obat oral/supp (anal/vaginal), inhalasi perawatan luka dengan didampingi CI/ Kepala ruang/ PJ 2. Melakukan perawatan jenazah dan menggunakan peralatan dan fasilitas secara mandiri 3. Melakukan komunikasi terapeutik dengan asertif pada pasien/keluarga, meliputi a. Penjelasan prosedur tindakan dan pengobatan b. Pendidikan kesehatan Dengan didampingi CI/Kaur/PJ 4. Mengajarkan latihan nafas dalam dan latihan batuk efektif 5. Melaporkan kondisi pasien/ pemeriksaan laboratorium per telephone ke dokter dengan didampingi PJ 6. Mengetahui dalam menyiapkan lumbal pungsi/pleura pungsi, dll 7. Memasang infus dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap
Minggu ke VII	1. Melakukan perawatan pasien dengan tingkat ketergantungan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 2. Melakukan kolaborasi dengan bagian lain, laboratorium,	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang

	radiologi, apotik, admin, dll dengan didampingi CI/ Kepala Ruang/ PJ 3. Menyiapkan pasien untuk BNO-IVP, endoscopy, colonoscopy, pemeriksaan laboratorium 4. Menyiapkan/ melaksanakan prosedur pre/post op			Rawat Inap
Minggu ke VIII	1. Mengikuti dalam persiapan pasien tindakan endoscopy, colonoscopy, MRI-MRA, MSCT 2. Mengikuti visite dokter dan didampingi (delegasi dari CI/ kepala Ruang/ PJ) 3. Menyiapkan pasien dan peralatan tindakan lumbal pungsi/ pleura pungsi, dll dengan didampingi CI/ kepala Ruang/ PJ	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap
Minggu ke IX	1. Melaksanakan tindakan keperawatan mandiri meliputi pemberian injeksi melalui injeksi IV/ IM/ SC/ IC, obat oral/supp (anal/vaginal), inhalasi, NGT, Dower Catheter, perawatan luka 2. Merawat pasien dengan tingkat ketergantungan secara mandiri 3. Mengikuti visiting dokter secara mandiri 4. Melakukan konsul internal dan eksternal dokter spesialis RSPH 5. Memasang infus secara mandiri	7 jam	Ceramah Membaca Diskusi Praktek	Komite Keperawatan Kepala Bidang Keperawatan Kepala Ruang Rawat Inap

BAB X

PERTEMUAN / RAPAT

Rapat berkala terdiri dari:

1. Rapat Rutin Koordinasi

Rapat Rutin diselenggarakan pada:

Waktu : Jumat (1 minggu sekali)

Jam : 13.00

Tempat : Hall RS Prima Husada

Peserta : Semua unit

Materi :

- 1) Pembacaan notulen rapat minggu lalu dan tindak lanjut
- 2) Pembacaan hasil Raker
- 3) Pembahasan laporan mingguan
- 4) Evaluasi kendala dan solusi

2. Rapat Kerja Bulanan RS

Rapat Rutin diselenggarakan pada:

Waktu : Setiap 1 bulan sekali

Jam : Menyesuaikan

Tempat : Ruang Rapat Hall

Peserta : Direksi, manajer, ketua komite, ka.Instalasi, ka.bagian

Materi :

- 1) Pembacaan notulen raker bulan lalu dan tindak lanjut
- 2) Presentasi laporan kinerja unit kerja
- 3) Evaluasi kendala dan solusi

3. Rapat Kerja Bulanan Unit

Rapat Rutin diselenggarakan pada:

Waktu : Setiap 1 bulan sekali

Jam : Menyesuaikan

Tempat : Ruang Rapat Hall

Peserta : kepala ruang/ kepala Unit, PJ Shift, Perawat Pelaksana

Materi :

- 1) Pembacaan notulen raker bulan lalu dan tindak lanjut
- 2) Presentasi laporan kinerja unit kerja
- 3) Pembahasan masalah yang ada di unit
- 4) Evaluasi kendala dan solusi

4. Rapat Insidentil

Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau sesuatu hal yang perlu dibahas segera.

BAB XI
PELAPORAN

Berikut data laporan instalasi NICU meliputi :

No	Jenis Laporan	Nama Laporan	Uraian Laporan
1	Laporan Harian	Laporan sensus harian	Laporan sensus harian meliputi tanggal laporan, shift yang bertugas, jumlah kesalahan, prosentase kesalahan, petugas tenaga medis yang melakukan kesalahan. Kepala ruangan yang bertanggung jawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada unit SDM setiap tiga bulan.
		Laporan rapor dokter	Laporan rapor dokter meliputi tanggal laporan, ketidak lengkapan assessment awal medis (DPJP) pasien rawat inap 1x24 jam. Kepala Ruang yang bertanggung jawab mengolah data tersebut dan melaporkan pada unit SDM setiap tiga bulan.
2	Laporan Bulanan	Laporan jadwal dinas tenaga medis	Laporan jadwal dinas NICU disusun oleh Kepala Ruang, yang disetujui oleh Kabid Pelayanan dan SDM.
		Laporan bulanan unit	Laporan bulanan unit disusun oleh Kepala Ruang melaporkan kebutuhan jumlah SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, kinerja produktivitas, mutu, evaluasi jadwal kegiatan, serta kritik dan saran dalam rangka perbaikan instalasi NICU.
3	Laporan Tahunan/ semester	Laporan evaluasi kinerja individu	Laporan evaluasi kinerja individu dilakukan oleh Kepala Ruang NICU untuk mengevaluasi kinerja perawat pelaksana. Hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan kinerja karyawan dan melakukan perbaikan apabila terdapat yang kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Oktober 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes